AMPLIADA, REVISADA E ATUALIZADA

2020

1.000 QUESTÕES COMENTADAS DE PROVAS E CONCURSOS EM ENFERMAGEM

INCLUI LÍNGUA PORTUGUESA,
MATEMÁTICA E INFORMÁTICA

INDICADO PARA

EBSERH | Residências Multiprofissionais
Secretarias de Saúde | Universidades
Tribunais (Tjs, TRTs e MPUs)
Ministério da Saúde | Polícia Civil

SANAR

2019
© Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos à Editora Sanar Ltda. pela Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume ou qualquer parte deste livro, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, gravação, fotocópia ou outros), essas proibições aplicam-se também à editoração da obra, bem como às suas características gráficas, sem permissão expressa da Editora.

Título | 1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Enfermagem 2020
Editoras | Karen Nina Nolasco e Thalita Galeão
Diagramação | Airton Oliveira
Capa | Didário Teles
Copisdesque | Micheline Luz Chahoud
Conselho Editorial | Caio Vinícius Menezes Nunes
Paulo Costa Lima
Sandra de Quadros Uzêda
Silvio José Albergaria da Silva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Tuxped Serviços Editoriais (São Paulo-SP)

P288q **Passinho,** Renata Soares

1.000 questões comentadas de provas e concursos em Enfermagem 2020 / Renata Soares Passinho. –
1. ed. - Salvador: Editora Sanar, 2019.
690 p.; il; 17x24 cm.

ISBN 978-85-5462-199-5

1. Concursos 2. Enfermagem 3. Exercícios 4. Problemas 5. Provas I. Título II. Autora

CDD 610.73
CDU 616.08

ÍNDICE PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO
1. Enfermagem.
2. Enfermagem.

Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Pedro Anizio Gomes CRB-8 8846

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

PASSINHO, Renata Soares. **1.000 questões comentadas de provas e concursos em Enfermagem 2020**. 1. ed. Salvador: Editora Sanar, 2019.

Editora Sanar Ltda.
Rua Alceu Amoroso Lima, 172
Caminho das Árvores,
Edf. Salvador Office & Pool, 3º andar.
CEP: 41820-770, Salvador - BA.
Telefone: 71.3052-4831
www.editorasanar.com.br
atendimento@editorasanar.com.br

Autores

COORDENADORA E AUTORA
Renata Soares Passinho

Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Servidora Pública Federal (Enfermeira) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Especialista, sob a forma de residência, em Saúde Materno Infantil pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e em Gestão de Emergências em Saúde Pública pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês. Aprovação em dois concursos públicos municipais (Salvador e Eunápolis) e dois federais (UFSB – 1º lugar e EBSERH UFBA – 3º lugar).

Andréa Tayse de Lima Gomes

Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Enfermeira graduada pela UFRN. Enfermeira Servidora Pública Federal da UFMG.

Brenda do Amaral Almeida

Doutoranda em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Enfermeira do Hospital Municipal de Macaé (RJ). Professora substituta de Enfermagem na UFRJ; Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Especialista em Enfermagem do Trabalho (UNINTER) e em Preceptoria do SUS (Hospital Sírio Libanês). Enfermeira do Trabalho pela Uninter. Bacharela e Licenciada em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Bruno Picanço

Formado em Matemática pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor voltado para Olimpíadas de Matemática, premiado por menção honrosa em 2018.

Chandra Lima Maciel

Mestre em Saúde Comunitária pelo Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva – UFBA. Enfermeira sanitarista graduada pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2009). Especialista em Saúde Pública e em Saúde da Família. Atualmente é Enfermeira concursada no Programa de Tratamento Fora Domicílio (TFD) lotada no Departamento de Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação do SUS da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus\BA.

Dayse Batista Santos

Mestre em Ensino e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC; Especialista em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia - ISC/UFBA. Enfermeira concursada, apoiadora institucional na educação permanente na Atenção Básica do município de Ilhéus/BA.

Elen Cristiane Gandra

Doutoranda e Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGE) da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista em Gestão de Emergências em Saúde Pública (Hospital Sírio Libanês). Enfermeira concursada do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Betim (MG).

Haroldo Ramanzini

Doutor em Linguística (UNESP) / Mestre em Teoria Literária (UNESP) / Bacharel e Licenciado em Letras (USP).

José Igor Silva Santos

Graduado em Enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Especialista em Urgência e Emergência em saúde pela Unigrad.

José Roberto Ancelmo

Atuou como especialista em informática e professor. Atuando com EAD Multidisciplinar desenvolvendo materiais didáticos voltados para o mercado EAD, como ebooks, exercícios, revisões e demais produtos. Assessoria em EAD a Faculdades e Universidades, também alunos de graduação e pós-graduação.

Josias Alves de Oliveira

Mestrando em Enfermagem e Saúde pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Graduado em Enfermagem (UNIJORGE); Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica e em Saúde, Desastres e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Laís Santos de Magalhães Cardoso

Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Escola de Engenharia da UFMG. Especialista em Saúde Coletiva (UFMG). Graduação em Enfermagem (bacharelado e licenciatura) pela Escola de Enfermagem da UFMG.

Laís Santana Santos Pereira Lira

Mestre Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Especialista em Saúde Mental (UESC). Servidora Pública Federal (Docente) no Instituto Federal da Bahia - IFBA/Eunápolis.

Maria Alice Souza Vieira

Mestranda do programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Enfermeira, graduada pela UFMG.

Milena Cerqueira Pitanga

Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Bacharel em Enfermagem pela UESC. Especialista em Saúde do Trabalhador e Enfermagem do Trabalho pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC). Docente da Faculdade Ruy Barbosa - DeVry Brasil, Salvador - BA.

Nathália Sales

Especialista em Enfermagem do Trabalho (UCAM). Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Professora em Saúde da Mulher e da Criança no curso online da Editora Sanar.

Nayanna Moreno Miranda Araújo

Mestranda em Avaliação pela Faculdade CESGRANRIO. Enfermeira do Trabalho concursada da empresa Petrobras. Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e em Auditoria em Sistemas de Saúde pelo Instituto Israelita Albert Einstein.

Paloma de Castro Brandão

Doutoranda em Saúde Coletiva pelo ISC/Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Ensino e Pesquisa/Hospital Sírio Libanês. Enfermeira concursada no SAMU 192 de Salvador – BA. Especialista, sob a forma de residência, em Terapia Intensiva Emergencista pela UFBA. Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Servidora Pública Federal (Docente) na Escola de Enfermagem da UFBA.

Rafael Rodrigues Polakiewicz

Doutorando em Ciências do Cuidado em Saúde na Universidade Federal Fluminense/UFF. Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde pela UFF. Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria (FAFIA). Graduado em Enfermagem pela UFF. Professor temporário da UFF.

Victor Porfirio Ferreira Almeida Santos

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia/UFBA. Especialista em Enfermagem Intensivista pela UFBA. Docente no Centro de Ensino Superior Estácio (FIB). Enfermeiro concursado do SAMU 192 de Salvador - BA. Bacharel em Enfermagem pela Faculdade Guanambi.

Apresentação

Olá, tudo bem?

Este livro foi pensado, planejado e concebido para você, **Enfermeira Concurseira**. Espero que esta obra faça a diferença em seus estudos e que o tão sonhado objetivo de ser aprovado na prova seja alcançado. Por este motivo, fizemos uma vasta análise no cenário de provas de concursos de **Enfermagem** nos últimos anos. Captamos questões dos mais diversos tipos de provas: prefeituras, EBSERH, tribunais e senado federal, forças armadas, títulos de especialista, dentre outros. Desta forma, conseguimos ter uma visão mais clara sobre os **conteúdos mais relevantes**. De acordo com este levantamento, agrupamos o conteúdo por tema e o número de questões será proporcional à sua relevância em concursos públicos. Este trabalho prévio nos permitiu criar um produto mais completo e mais eficiente que atende às necessidades de uma enfermeira que prestará concurso público.

Oi, eu sou a @_enfermeira_concurseira serei a sua assistente de estudos e espero que este livro possa te auxiliar em sua jornada. Para isso, preste atenção nas dicas de estudo que eu trouxe para você, combinado?

Vamos às ferramentas didáticas:

- **DICAS DE ESTUDO.** Planejamento da rotina de estudos baseado na proposta pedagógica do livro. Mais detalhes sobre esta ferramenta podem ser lidos no tópico: "Como ler este livro".
- **CRIANDO SEUS PRÓPRIOS RECURSOS.** Traremos para você dicas para criarem seus resumos, mapas mentais, focar nos estudos e se organizar da melhor maneira possível!
- **QUESTÕES CATEGORIZADAS.** Todas as questões são organizadas por assuntos e por grau de dificuldade, de acordo com o seguinte modelo:
- **COMENTÁRIOS EM CADA ALTERNATIVA.** Todas as alternativas possuem breves comentários, independentemente de estarem certas ou erradas.

FÁCIL	●
INTERMEDIÁRIO	● ●
DÍFICIL	● ● ●

- **DICA DO AUTOR.** Explicação adicional aos comentários das alternativas. Aparecerá nas questões que o autor julgar importante incluir este recurso.
- **RESUMO PRÁTICO.** Síntese do assunto abordado nas questões estruturado de forma esquematizada.
- **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.** As fontes utilizadas privilegiam os livros mais recomendados em editais e estão devidamente identificadas nas referências.

Como ler este livro?

1. Para começar, preciso lhe dizer que este livro não é um livro qualquer!

2. Acreditamos que a ausência de um método de estudo é o principal fator de reprovação. Como o nosso papel é ajudá-lo a alcançar o seu sonho de ser aprovado em um concurso público, incluímos nesta obra um roteiro de estudo para guiá-lo e alimentá-lo com as ferramentas necessárias ao aprendizado.

3. Então as suas missões são: estudar, consumir e devorar estas páginas!
   Esteja livre para rabiscar, sublinhar, destacar, circular e escrever! O importante é produzir e garantir o seu sucesso nas provas!

4. O nosso objetivo é ajudá-lo a conquistar a sua meta! Muitas vezes, encorajando-o e incentivando-o para continuarmos juntos na missão!

Quem avisa, amigo SANAR é...

COMO FAZER UM BOM RESUMO?

1. L E I A com atenção
2. Marque/grife as **palavras-chave** → Conceitos
3. Escreva o resumo com as suas próprias palavras
4. Organize as ideias principais
5. Faça muitos exercícios para fixar o assunto! Pode ser logo após a leitura, no fim de semana... Faça o que for melhor de acordo com a sua rotina, mas sempre organizando o seu planner de estudos!

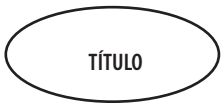
Como se manter focado nos estudos?

1. Organize o seu tempo
2. Evite distrações
3. Exercite seu conhecimento resolvendo as questões e depois analise os comentários validando seu raciocínio
4. Leia os resumos práticos com bastante atenção e quando necessário, assista a videoaulas.

Como fazer um mapa mental?

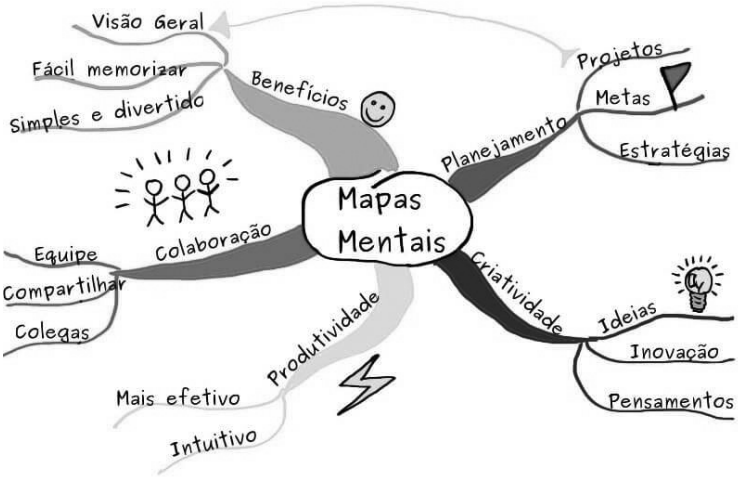
O mapa mental é uma ferramenta para organizar, memorizar ou analisar um conteúdo específico.

1. Identifique de onde virá a informação e qual o seu OBJETIVO.
2. Comece com o TÍTULO. Coloque-o no CENTRO da folha, normalmente dentro de uma elipse.



3. A partir do título, puxe linhas que representam INFORMAÇÕES ASSOCIADAS AO TÍTULO. É recomendado que essas informações sejam apenas palavras.
4. O ideal é COLORIRMOS o nosso mapa mental! Junte aí as suas canetas coloridas!
5. Use FIGURAS e DESENHOS o máximo que você puder para solidificar ainda mais as informações.
6. TREINE! O mapa mental pode ser a ferramenta para que o seu cérebro organize melhor as informações. A prática leva à perfeição!

ILUSTRAÇÃO DE MAPA MENTAL



De olho no edital!

Faça aqui o acompanhamento dos próximos editais das provas que você irá realizar e em breve virá a sua aprovação!

A organização, estudo e acompanhamento é fundamental!

Checklist do edital

- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

Sumário

1. Legislação Profissional e Epistemologia em Enfermagem 15
   1. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 15
   2. Conselho Federal de Enfermagem e Respectivas Resoluções 21
   3. Lei do Exercício Profissional 22
   4. Teorias de Enfermagem 25
   5. Processo de Enfermagem 27

RESUMO PRÁTICO 29

2. Gerenciamento em Enfermagem 37
   1. Teorias Administrativas 37
   2. Auditoria em Enfermagem 38
   3. Planejamento em Enfermagem 40
   4. Gerenciamento de Recursos materiais 41
   5. Escalonamento do pessoal de enfermagem 44
   6. Liderança em Enfermagem 44

RESUMO PRÁTICO 45

3. Fundamentos de Enfermagem e Propedêutica Clínica 51
   1. Curativos e Cuidados com a Ferida 51
   2. Propedêutica Clínica 65
   3. Intervenções de Enfermagem 78
   4. Sinais Vitais 81
   5. Coleta de Amostra para Exames 84
   6. Administração e Cálculo de Medicamentos 88

RESUMO PRÁTICO 97

4. Legislação do Sistema Único de Saúde 111
   1. Constituição Federal de 1988 111
   2. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde 116
   3. Lei nº 8.142/1990 122
   4. Lei nº 8.080/1990 128
   5. Norma Operacional Básica e Norma Operacional de Assistência à Saúde 140
   6. Decreto nº 7.508/2011 142
   7. Pacto pela Saúde 146
   8. Resolução nº 453/2012 148

RESUMO PRÁTICO 150

5. Enfermagem em Saúde Coletiva 157
   1. Epidemiologia 157
      1. Doenças e Agravos de Notificação Compulsória 162

2. Sistemas de Informação 167
3. Determinantes Sociais em Saúde 168
2. Políticas e Programas em Saúde Coletiva 169
1. Política Nacional de Atenção Básica 169
2. Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 - Atenção Domiciliar 199
3. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 200
4. Política Nacional de Atenção às Urgências 202
5. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 206
6. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 207
7. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 208
8. Política Nacional de Humanização 209
9. Programa de Saúde na Escola 212
10. Programa Nacional de Imunização 213

RESUMO PRÁTICO 216

6. Enfermagem em Urgência e Emergência 229
1. Ressuscitação Cardiorrespiratória 229
2. Choque 237
3. Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) 238
4. Trombose Venosa 239
5. Intoxicações e Envenenamentos 239
6. Emergências Cardiovasculares 241
7. Trauma 244
8. Emergências Endócrinas 250
9. Acolhimento com Classificação de Risco 251
10. Emergências Neurológicas, Coma e Rebaixamento do Nível de Consciência 252
11. Hemorragia Digestiva 254
12. Abordagem Intensiva ao Paciente Grave 255

RESUMO PRÁTICO 256

7. Enfermagem Clínica e Cirúrgica 287
1. Enfermagem Clínica 287
1. Doenças Crônicas Não Transmissíveis 287
Hipertensão Arterial Sistêmica 288
Diabetes Mellitus 292
2. Doenças Diarreicas Agudas 304
3. Doenças Neurológicas 306
4. Distúrbios Acidobásicos 307
5. Doenças Cardiovasculares 309
6. Doenças Respiratórias 313
7. Doenças Renais 316
8. Doenças Gastrintestinais 317
2. Enfermagem Cirúrgica 318
1. Cuidados Pré, Intra e Pós-Operatórios 318
2. Sala de Recuperação Pós-Anestésica 319
3. Complicações Cirúrgicas 320
4. Feridas Cirúrgicas 321
5. Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização 321

RESUMO PRÁTICO 325

8. Enfermagem em Infectologia....345
1. Infecções Sexualmente Transmissíveis....345
2. Doenças Imunopreveníveis....349
3. Hanseníase....355
4. Tuberculose....358
5. Arboviroses....362

RESUMO PRÁTICO....364

9. Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente....371
1. Avaliação e Cuidados ao Recém-Nascido....371
2. Triagem Neonatal....378
3. Emergências Neonatais....380
4. Crescimento e Desenvolvimento da Criança....380
5. Saúde do Adolescente e Estatuto da Criança e do Adolescente....384

RESUMO PRÁTICO....391

10. Enfermagem em Saúde da Mulher....403
1. Enfermagem Ginecológica....403
2. Pré-natal....410
3. Trabalho de Parto e Parto....415
4. Complicações Obstétricas....422
5. Puerpério....425
6. Violência Contra a Mulher....427

RESUMO PRÁTICO....429

11. Enfermagem em Saúde do Trabalhador....437
1. Organização Internacional do Trabalho....437
2. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora....438
3. Legislação Trabalhista e Previdenciária....441
4. Fator Acidentário de Prevenção....441
5. Acidente de Trabalho e Comunicação de Acidente de Trabalho....442
6. Doenças Profissionais e Doenças Relacionadas ao Trabalho....444
7. Atribuições do Enfermeiro do Trabalho....447
8. Norma Regulamentadora nº 5....447
9. Norma Regulamentadora nº 6....448
10. Norma Regulamentadora nº 7....448
11. Norma Regulamentadora nº 9 e Elementos da Higiene Ocupacional....452
12. Norma Regulamentadora nº 15....453
13. Norma Regulamentadora nº 17 e Ergonomia Aplicada ao Trabalho....454

RESUMO PRÁTICO....457

12. Enfermagem em Saúde Mental....471
1. Reforma Psiquiátrica....471
2. Centro de Atenção Psicossocial e Outros Serviços Substitutivos....472
3. Articulação entre Saúde Mental e Atenção Básica....474
4. Rede de Atenção Psicossocial....477
5. Transtornos Mentais....478
6. Emergências Psiquiátricas....483

7. Tratamento Medicamentoso 483
8. Atuação do Enfermeiro em Saúde Mental 484

RESUMO PRÁTICO 487

13. Português 513

RESUMO PRÁTICO 566

14. Matemática 603

RESUMO PRÁTICO 638

15. Informática 645

RESUMO PRÁTICO 679

Enfermagem em Saúde da Criança

9

Dayse Batista Santos

1. AVALIAÇÃO E CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO

01 **(PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PB - COTEMAX - 2019)** A hemorragia abaixo da aponeurose epicraniana, que conecta os componentes frontal e occipital dos músculos fronto-occipitais, que apresenta-se como massa de consistência firme a flutuante, às vezes se estendendo para o pescoço ou fronte, é um dos achados no exame físico do recém-nascido, (RN) denominado:

Ⓐ Bossa serossanguínea.
Ⓑ Caput succedaneum.
Ⓒ Céfalo-hematoma.
Ⓓ Hematoma subgaleal.
Ⓔ Dolicocefalia.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ **DICA DO AUTOR:** A questão exige bastante atenção. Mas, considerando a objetividade e clareza dos conceitos de cada alternativa, o seu grau de dificuldade abranda. Importa ao candidato atentar na hora das anotações.

Alternativa A: INCORRETA. Também conhecida como capput succedaneum, a bossa serossanguínea, como indica o nome, é uma bossa no couro cabeludo, causada pela pressão exercida pelo útero e cérvix sobre a cabeça do feto durante o parto. Caracteriza-se por ser uma massa mal limitada e mole, edemaciada e equimótica, a qual, embora inicialmente se restrinja à área de apresentação do parto, pode se deslocar para outras regiões, conforme o decúbito. Desaparece nos primeiros dias de vida.[1,2]

Alternativa B: INCORRETA. Caput succedaneum ou bossa serossanguínea, conforme já apresentado na alternativa A, é a alteração mais frequentemente encontrada após o nascimento.[2]

Alternativa C: INCORRETA. Define-se enquanto céfalo-hematoma a coleção sanguínea subperiostal ou derrame sanguíneo subperióstico, de consistência cística e volume variável, que se desenvolve após o parto e se expande durante o primeiro dia de vida, à medida que o sangue se acumula. É arredondado e limitado a um osso. Ocasionalmente, pode haver fratura subjacente, podendo também ser causa de hiperbilirrubinemia.[3]

Alternativa D: CORRETA. Hematoma subgaleal é o termo que define a hemorragia abaixo da aponeurose epicraniana, que conecta os componentes frontal e occipital dos músculos fronto-occipitais e que se apresenta como massa de consistência firme a flutuante, às vezes se estendendo para o pescoço ou fronte. É um dos achados no exame físico do recém-nascido (RN). Com borda definida, pode apresentar crepitação durante a palpação, principalmente na periferia [3]

Alternativa E: INCORRETA. Dolicocefalia é o alongamento do crânio, também conhecido como escafocefalia.[4]

---

02 **(PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - PB - COTEMAX - 2019)** Atenção especial deve ser dada para a face do RN, observando-se a harmonia, simetria e proporcionalidade dos componentes da face. O enfermeiro deve procurar características faciais peculiares, que auxiliam no diagnóstico de síndromes genéticas. Qual das síndromes apresentadas a seguir NÃO apresenta traços identificáveis na face?

Ⓐ Síndrome de Down.
Ⓑ Síndrome de Potter.
Ⓒ Síndrome de Crouzon.
Ⓓ Síndrome de Apert.
Ⓔ Síndrome de Yamaguchi.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ **DICA DO AUTOR:** Causas de grande exclusão social, as síndromes genéticas necessitam de atenção especial, pois algumas características que trazem são, algumas vezes, traços fenotípicos simples de alguns indivíduos. O seu estudo aprofundado, além de evitar possíveis sequelas precocemente evitáveis, representa um caminho para o estímulo à inclusão social e promoção de melhor qualidade de vida para os seus portadores.

Alternativa A: INCORRETA. A face das crianças com Síndrome de Down é caracterizada por pregas palpebrais oblíquas para cima, epicanto (prega cutânea no canto interno do olho), sinófris (união das sobrancelhas), base nasal plana, face aplanada, protusão lingual, palato ogival (alto), orelhas de implantação baixa, pavilhão auricular pequeno e pelo cabelo fino.[5]

Alternativa B: INCORRETA. A Síndrome de Potter representa uma condição na qual o recém-nascido, pela ausência de líquido amniótico (oligo-hidrâmnio), fica desprotegido da parede do útero. Nessa situação, a pressão exercida por essa parede provoca uma aparência facial típica (fácies de Potter): olhos amplamente separados, com pregas epicânticas, ponte nasal ampla, implantação baixa das orelhas e queixo retraído.[6]

Alternativa C: INCORRETA. Tríade composta por deformidades do crânio, anomalias faciais e exoftalmia, a síndrome de Crouzon caracteriza-se pelo fechamento prematuro de suturas cranianas e a sinostose prematura de suturas centrofaciais e da base do crânio, ocasionando crescimento ósseo anormal e produção de deformidades faciais. Embora frequentemente se apresente aos dois anos de idade, existem formas precoces congênitas nas quais a sinostose se desenvolve ainda dentro do útero, sendo percebida ao nascimento por deformidades faciais como a hipoplasia maxilar superior, responsável por dificuldades respiratórias e exoftalmia.[7,8]

Alternativa D: INCORRETA. Ao exame físico, a Síndrome de Apert apresenta face ligeiramente achatada e assimétrica, hipertelorismo e proptose ocular associada à depressão das fissuras palpebrais laterais, com um sulco profundo transversal acima da região supra-orbital, o que lhe dá um aspecto de envelhecimento precoce. O nariz pequeno, com largura desproporcional ao comprimento, associado à ponte nasal deprimida, sugerindo um aspecto de "nariz de papagaio", é uma outra característica marcante. O terço médio da face hipoplásica, o ângulo nasolabial diminuído, exibindo ausência de selamento labial e respiração bucal, e as orelhas largas deslocadas para baixo são outros traços identificáveis na face.[9]

Alternativa E: CORRETA. A Síndrome de Yamaguchi é uma variante da cardiomiopatia hipertrófica, caracterizada pela hipertrofia apical do ventrículo esquerdo (VE), com maior incidência entre os japoneses.[10]

---

03 **(SES - DF - IADES - 2018)** Ao exame físico do recém-nascido, palidez geralmente sugere a existência de uma anemia e/ou vasoconstrição periférica. O aparecimento de palidez em um hemicorpo e vermelhidão no lado oposto sugerem alteração vasomotora, achado semiológico conhecido como pele de:

Ⓐ Sereia.
Ⓑ Lontra.
Ⓒ Dragão.
Ⓓ Porcelana.
Ⓔ Arlequim.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ **DICA DO AUTOR:** A questão necessita de atenção, para que o candidato não a responda por simples analogia.

Resolução: O aparecimento de palidez em um hemicorpo e vermelhidão no lado oposto sugerem alteração vasomotora, achado semiológico conhecido como pele de arlequim. Vindo do grego "ichthys", o termo significa peixe, usado devido ao aspecto escamoso da pele dos doentes. Na sua forma mais severa, a pele apresenta-se com placas córneas espessas, em formas geométricas, separadas por fissuras, caracterizando o "feto arlequim" (as placas lembram o padrão diamante dos trajes de Arlequim - personagem da antiga comédia italiana de traje multicolor em losango).[11]

Resposta: Ⓔ

---

04 **(PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS - MG - FADENOR - 2019)** O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância fundamental para a redução da mortalidade infantil, ainda elevada no Brasil, assim como a promoção de melhor qualidade de vida e a diminuição das desigualdades em saúde. Com relação à avaliação e cuidados com o recém-nascido, pode-se afirmar que:

Ⓐ A Escala ou Índice de Apgar é o método mais comumente empregado para avaliar o ajuste imediato do recém-nascido à vida extrauterina e deve ser realizado nos dez e quinze minutos de vida.
Ⓑ Proteção ocular, controle de temperatura, controle de diurese e mudança de decúbito são cuidados essenciais com o recém-nascido em fototerapia.
Ⓒ A Tabela de Kramer relaciona os níveis de bilirrubina indireta (BI) à zona dérmica de icterícia, em que a cabeça, pescoço e tórax correspondem à zona I ou icterícia de grau I.
Ⓓ O Método de Capurro é amplamente utilizado para avaliar o desconforto respiratório do recém-nascido prematuro.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A Escala ou Índice de Apgar deve ser realizado no primeiro e no quinto minuto após o nascimento.[12,13]

Tabela para cálculo do Índice de Apgar:

PONTOS	0	1	2
Frequência cardíaca	Ausente	<100/min	>100/min
Respiração	Ausente	Fraca, irregular	Forte/ choro
Tônus muscular	Flácido	Flexão de pernas e braços	Movimento ativo/Boa flexão
Cor da pele	Cianótico/ Pálido	Cianose de extremidades	Rosado
Irritabilidade Reflexa	Ausente	Algum movimento	Espirros/ Choro

Fonte: Brasil,2014.

Alternativa B: CORRETA. Um dos principais cuidados durante a fototerapia deve ser a proteção ocular com a utilização de protetor radiopaco, apropriado para prevenir a exposição à luz. O controle da temperatura corporal deve ser frequentemente realizado, a fim de detectar hipotermia ou hipertermia. Da mesma forma, o controle da diurese precisa ser monitorado, pois a fototerapia pode provocar elevação da temperatura, da frequência respiratória e do fluxo sanguíneo na pele, com maior perda insensível de água. Orienta-se a mudança de decúbito de 3 em 3 horas, com avaliação do estado da pele, registro e comunicação de possíveis alterações e intolerância do RN.[14]

Alternativa C: INCORRETA. A principal causa de icterícia patológica e de doença hemolítica neonatal é a incompatibilidade sanguínea materno-fetal, que cursará com redução de hematócrito, aumento dos níveis séricos de BT e reticulócitos >5%. A digitopressão sobre a pele, sob luz natural, permite a classificação da icterícia nas zonas de Kramer ou zonas dérmicas. Conforme a tabela de Kramer, a zona I ou icterícia de grau I corresponde à cabeça e pescoço. O tórax está concentrado na zona II.[15]

Tabela de Kramer:

ZONA	Local	Níveis Séricos de Bilirrubina
Zona 1	Cabeça e pescoço	4 a 8 mg/dl, média 6 mg/dl
Zona 2	Tronco até umbigo	5 a 12 mg/dl, média 9 mg/dl Zona
Zona 3	Hipogástrio até coxas	8 a 17 mg/dl, média 12 mg/dl
Zona 4	Braços, antebraços e pernas	11 a 18 mg/dl, média 15 mg/dl
Zona 5	Mãos e pés	>15 mg/dl, média >18 mg/dl

Fonte: Brasil, 2012.21

Alternativa D: INCORRETA. O Método de Capurro é o método comumente usado para realização de exame somato-neurológico dos recém-nascidos com idade gestacional maior que 28 semanas, podendo ser realizado logo ao nascer (método somático).[16]

---

05 **(PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - SP - CONSULPAM - 2018)** Quando o recém-nascido está com boa vitalidade e não necessita de manobras de reanimação e devem ser realizadas as seguintes intervenções, EXCETO:

Ⓐ Proceder ao clampeamento do cordão umbilical após cessadas suas pulsações (aproximadamente 1 a 3 minutos), nos casos de mães isoimunizadas ou HIV /HTLV positivas. Nos outros casos, o clampeamento deve ser imediato.
Ⓑ Manter o RN sobre o abdome e/ou tórax materno, usando o corpo da mãe como fonte de calor, garantindo que o posicionamento da criança permita movimentos respiratórios efetivos. O contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente de 26°C, reduz o risco de hi-

potermia em RNs a termo com respiração espontânea e que não necessitam de ventilação, desde que cobertos com campos preaquecidos.
Ⓒ Realizar o aleitamento precoce para promoção do contato mãe-bebê imediato após o parto, evitando intervenções desnecessárias, que interferem nessa interação nas primeiras horas de vida. Deve ser estimulado o contato pele a pele e o aleitamento materno na primeira hora de vida, exceto em casos de mães HIV ou HTLV positivos.
Ⓓ Administrar vitamina K para prevenção do sangramento, 1mg de vitamina K por via intramuscular ao nascimento.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ **DICA DO AUTOR:** Questão simples, que exige concentração do candidato. Os cuidados iniciais direcionados ao recém-nascido influenciam diretamente na sua qualidade de vida. Este é um tema sempre presente na maioria das provas, que exige atenção especial do estudante e profissionais da saúde. O candidato deve atentar que o enunciado da questão solicita a marcação da alternativa INCORRETA.
Alternativa A: INCORRETA. Ao contrário do que apresenta a questão, a Portaria 371, de 07 de maio de 2014, no seu Art. 4º, parágrafo segundo, orienta que é necessário proceder ao clampeamento do cordão umbilical, após cessadas suas pulsações (aproximadamente, de 1 a 3 minutos), exceto em casos de mães isoimunizadas ou HIV HTLV positivas, nesses casos o clampeamento deve ser imediato. O Ministério da Saúde, através do Manual de Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal (2017), orienta a realização do clampeamento do cordão umbilical entre 1 e 5 minutos ou de forma fisiológica, quando cessar a pulsação, exceto se houver alguma contraindicação em relação ao cordão ou necessidade de reanimação neonatal. Ainda conforme as diretrizes, se uma mulher solicitar o clampeamento e a secção do cordão após 5 minutos, apoiá-la em sua escolha.[17]
Alternativa B: CORRETA. Intervenção deve ser realizada.
Alternativa C: CORRETA. Intervenção deve ser realizada.
Alternativa D: CORRETA. Intervenção deve ser realizada.

---

06 **(PREFEITURA MUNICIPAL DE COITEGI - PB - CPCON - 2018)** Na atenção à saúde da criança, o exame físico completo deve ser realizado na primeira consulta do recém-nascido e nas consultas subsequentes. Durante o exame físico, os valores da frequência respiratória devem ser avaliados. Associe a primeira coluna de acordo com a segunda, em relação aos valores normais da frequência respiratória de crianças.

De 0 a 2 meses	( ) Até 40 mrm
De 2 a 11 meses	( ) Até 30 mrm
De 12 meses a 5 anos	( ) Até 60 mrm
De 6 a 8 anos	( ) Até 50 mrm
Acima de 08 anos	( ) Até 20 mrm

A sequência CORRETA dessa associação é:

Ⓐ 3, 4, 1, 2 e 5.
Ⓑ 2, 3, 5, 1 e 4.
Ⓒ 3, 5, 1, 4 e 2.
Ⓓ 4, 5, 3, 2 e 1.
Ⓔ 4, 2, 1, 3 e 5.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Define-se enquanto frequência respiratória normal, de 0 a 2 meses: até 60mrm; de 2 a 11 meses: até 50mrm; de 12 meses a 5 anos: até 40mrm; de 6 a 8 anos: até 30mrm; e acima de 8 anos: até 20mrm.[14]

Resposta: Ⓐ

---

07 **(PREFEITURA DE GUARAJÁ DO SUL - SC - AMEOSC - 2019)** A temperatura corporal é o resultado do balanço entre os mecanismos de produção e de eliminação do calor. No recém-nascido (RN), sobretudo no pré-termo, pode ocorrer desequilíbrio desses mecanismos, com aumento nas perdas e limitação na produção. É exemplo de condição ligada à diminuição da produção de calor:

Ⓐ Menor mobilização de noradrenalina e ácidos graxos livres.
Ⓑ Baixa temperatura ambiental.
Ⓒ Menor capacidade de vasoconstrição cutânea.
Ⓓ Epiderme não queratinizada.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. As perdas e limitação na produção da temperatura corporal no RN tem como fatores a menor mobilização de noradrenalina e ácidos graxos livres, o menor estoque de gordura marrom, a menor resposta termogênica por hipóxia, restrição do crescimento intrauterino e doenças e o consumo de O_2 limitado por problemas pulmonares.[18]

RESUMO PRÁTICO

EXAME FÍSICO

A realização da anamnese materna e o conhecimento da idade gestacional são fatores relevantes a serem considerados durante o exame físico do RN. O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. Essas faixas etárias são selecionadas porque representam momentos de oferta de imunizações e de orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças.[14] Outras informações também necessitam ser consideradas, sendo importante a compreensão de alguns termos.

Idade gestacional	Duração da gestação medida do primeiro dia do último período normal de menstruação até o nascimento; expressa em dias ou semanas completas.
Pré-termo	Menos do que 37 semanas completas (menos do que 259 dias completos).
Prematuro tardio	De 34 semanas a 36 e 6 e 6 dias
Termo	De 37 semanas completas até menos de 42 semanas completas (259 a 293 dias).
Pós-termo	42 semanas completas ou mais (294 dias ou mais).
Período neonatal	Intervalo de tempo que vai do nascimento até o momento em que a criança atinge 27 dias, 23 horas e 59 minutos.
Período neonatal precoce	Intervalo de tempo que vai do nascimento até o momento em que a criança atinge 6 dias, 23 horas e 59 minutos.
Período neonatal tardio	Intervalo de tempo que vai do 7º dia até o momento em que a criança atinge 27 dias, 23 horas e 59 minutos.
Idade pós-natal	É o período de tempo que decorre do nascimento até a data presente.
Idade corrigida	É a idade pós-natal menos o número de semanas que faltou para completar 40 semanas (subtrair da idade pós-natal a diferença entre 40 semanas e a idade gestacional). É usada para avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança após o termo.
Peso de nascimento	Primeiro peso do recém-nascido (RN) obtido após o nascimento. Nos casos onde o contato pele a pele da primeira hora de vida foi estabelecido, realizar a pesagem a posteriori. • Baixo peso: peso ao nascer inferior a 2.500 gramas. • Muito baixo peso: peso ao nascer inferior a 1.500 gramas. • Extremo baixo peso: peso ao nascer inferior a 1.000 gramas.

Fonte: Brasil, 2013.

O índice de Apgar: no quinto minuto entre 7 e 10 é considerado normal. Apgar 4, 5 ou 6 é considerado intermediário e relaciona-se, por exemplo, com prematuridade, medicamentos usados pela mãe, má-formação congênita, o que não significa maior risco para disfunção neurológica. Índices de 0 a 3 no quinto minuto relacionam-se a maior risco de mortalidade e leve aumento de risco para paralisia cerebral. No entanto, um baixo índice de Apgar, isoladamente, não prediz disfunção neurológica tardia.[16]

Tabela para cálculo do índice			
Pontos	0	1	2
Frequência cardíaca	Ausente	< 100 / min	> 100/ min
Respiração	Ausente	Irregular/ Bradipneia	Forte / Choro
Tônus muscular	Flácido	Flexão de pernas e braços	Movimento ativo/ Boa flexão
Cor	Cianose Central/ Palidez	Cianose de extremidades	Rosado
Reflexo/ Irritabilidade	Ausente	Algum movimento/ Careta	Espirros / Choro

Tabela para cálculo do índice			
Pontos	0	1	2
Frequência cardíaca	Ausente	<100/min	>100/min
Respiração	Ausente	Irregular/Bradipneia	Forte/Choro
Tônus muscular	Flácido	Flexão de pernas e braços	Movimento ativo/ Boa flexão
Cor	Cianose Central/Palidez	Cianose de extremidades	Rosado
Reflexo/Irritabilidade	Ausente	Algum movimento/ Careta	Espirros/Choro

Fonte: Brasil, 2013.

Tópicos do exame físico na primeira consulta do recém-nascido:

Tópicos do exame físico	Ações específicas
Peso, comprimento e perímetro cefálico	Avalie o comprimento e o perímetro cefálico da criança. Avalie o peso em relação ao peso ideal ao nascer. Consideram-se normais tanto uma perda de peso de até 10% ao nascer quanto a sua recuperação até o 15º dia de vida. O perímetro cefálico com medidas acima ou abaixo de dois desvios-padrão (< -2 ou > +2 escores "z") pode estar relacionado a doenças neurológicas, como microcefalia (de causa genética ou ambiental) e hidrocefalia, o que exige, portanto, melhor avaliação e encaminhamento.
Desenvolvimento social e psicoafetivo	Observe e avalie o relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê: como respondem às suas manifestações, como interagem com o bebê e se lhe proporcionam situações variadas de estímulo.
Estado geral	Avalie a postura normal do recém-nascido: as extremidades fletidas, as mãos fechadas e o rosto, geralmente, dirigido a um dos lados. Observe o padrão respiratório: a presença de anormalidades, como batimentos de asas do nariz, tiragem intercostal ou diafragmática e sons emitidos. Avalie o estado de vigília do recém-nascido: o estado de alerta, o sono leve ou profundo e o choro. Identifique sinais de desidratação e/ou hipoglicemia: pouca diurese, má ingestão (a criança não consegue mamar ou vomita tudo o que mama), hipoatividade e letargia. A temperatura axilar normal situa-se entre 36,4ºC e 37,5ºC e não necessita ser medida rotineiramente em crianças assintomáticas, exceto na presença de fatores de risco, como febre materna durante o parto.
Face	Pesquise alguma assimetria, má-formação, deformidade ou aparência sindrômica.
Pele	Observe a presença de: (a) edema (se for generalizado, pense em doença hemolítica perinatal, iatrogenia por uso de coloides ou cristaloides em excesso, insuficiência cardíaca, sepse; se for localizado, isso sugere trauma de parto); (b) palidez (sangramento, anemia, vasoconstrição periférica ou sinal de arlequim – palidez em um hemicorpo e eritema do lado oposto, por alteração vasomotora e sem repercussão clínica); (c) cianose (se for generalizada, pense em doenças cardiorrespiratórias graves; se for localizada nas extremidades ou na região perioral, pense em hipotermia); (d) icterícia. O profissional deverá estar mais atento, caso a icterícia tenha se iniciado nas primeiras 24 horas ou depois do 7º dia de vida, caso tenha duração maior do que uma semana no recém-nascido a termo, duração maior do que duas semanas no prematuro e se a tonalidade for amarela com matiz intenso ou se a icterícia se espalha pelo corpo, atingindo pernas e braços. Pesquise a possível presença de assaduras, pústulas (impetigo) e bolhas palmo-plantares (sífilis). Esclareça a família quanto à benignidade do eritema tóxico.

SÍFILIS CONGÊNITA

Conforme relato do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA,2018), em comparação ao ano de 2016, observou-se aumento de 28,5% na taxa de detecção em gestantes, 16,4% na incidência de sífilis congênita e 31,8% na incidência de sífilis adquirida. Entre gestantes, cresceu de 10,8 casos por 1 mil nascidos vivos em 2016 para 17,2 casos a cada 1 mil nascidos vivos em 2017. Já a sífilis congênita passou de 21.183 casos em 2016 para 24.666 em 2017. O número de óbitos por sífilis congênita foi de 206 casos em 2017, maior que em relação a 2016, quando foram registrados 195 casos.[5]

Fonte: (Brandelli, 2017).

ALEITAMENTO MATERNO

O leite materno é o alimento mais completo que um bebê pode receber desde o seu nascimento. Devendo ser sua alimentação exclusiva até os seis meses de idade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca quatro pontos-chave que caracterizam o posicionamento e pega adequados:[46]

Pontos-chave do posicionamento adequado:

- Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo.
- Corpo do bebê próximo ao da mãe.
- Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido).
- Bebê bem apoiado.

Pontos-chave da pega adequada:

- Mais aréola visível acima da boca do bebê.
- Boca bem aberta.
- Lábio inferior virado para fora.
- Queixo tocando a mama.

BENEFÍCIOS[46]:

Para o bebê:

- Maior contato com a mãe.
- Melhora a digestão e minimiza as cólicas.
- Desenvolve a inteligência quanto maior for o tempo de amamentação.
- Reduz o risco de doenças alérgicas.
- Diminui as chances de desenvolver doença de Crohn e linfoma.
- Estimula e fortalece a arcada dentária.
- Previne contra doenças contagiosas, como a diarreia.

Para a mãe:

- Diminui o sangramento no pós-parto.
- Acelera a perda de peso.
- Reduz a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio.
- Evita a osteoporose.
- Protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto.

Fonte: maespecialista.2018.

TRIAGEM NEONATAL

Conforme publicação do Ministério da Saúde[47], são os chamados exames da triagem neonatal:

Teste do Pezinho – Realizado preferencialmente entre o 3° e o 5° dia de vida, o teste do pezinho é uma das principais formas de diagnosticar seis doenças que, quanto mais cedo forem identificadas, melhores são as chances de tratamento. São elas: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Realizado na rede de Atenção Básica, hospitais e maternidades.
Teste do Olhinho – É um exame simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um refle-

xo vermelho, que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do bebê. O fenômeno é semelhante ao observado nas fotografias. O "Teste do Olhinho" pode detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma congênito e outros problemas – cuja identificação precoce pode possibilitar o tratamento no tempo certo e o desenvolvimento normal da visão. O exame é realizado nas maternidades públicas até a alta do recém-nascido.

Teste da Orelhinha – Entre os procedimentos realizados ainda na maternidade, logo após o nascimento do bebê, está a triagem neonatal auditiva ou o teste da orelhinha. O exame é feito, geralmente, no segundo ou terceiro dia de vida do bebê e identifica problemas auditivos no recém-nascido. Desde 2010 é determinado por lei que nenhuma criança saia da maternidade sem ter feito o teste, que é gratuito. As crianças nascidas fora do ambiente hospitalar devem fazê-lo antes de completarem 3 meses de vida. O Teste da Orelhinha é realizado com o bebê dormindo, em sono natural, é indolor e não machuca, não precisa de picadas ou sangue do bebê, não tem contraindicações e dura em torno de 10 minutos.

Teste do Coraçãozinho – Todo bebê tem direito de realizar o teste de coraçãozinho ainda na maternidade, entre 24h e 48h após o nascimento. O teste é simples, gratuito e indolor. Consiste em medir a oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos do recém-nascido com o auxílio de um oxímetro – espécie de pulseirinha – no pulso e no pé do bebê. Caso algum problema seja detectado, o bebê é encaminhado para fazer um ecocardiograma. Se alterado, é encaminhado para um centro de referência em cardiopatia para tratamento.

IMUNIZAÇÃO

O reaparecimento de algumas doenças, como sarampo, poliomielite, rubéola e difteria, tem preocupado profissionais de saúde. A baixa cobertura vacinal é o fator determinante para o retorno de tais doenças e a este respeito o Ministério da Saúde, por meio de nota, informa que tal ocorrência acende a "luz vermelha", o que exige alerta e cuidado por parte de todos. Durante a infância, o acompanhamento ao calendário vacinal deve ser uma prioridade para os profissionais de saúde e para os pais ou responsáveis, buscando garantir a máxima proteção dos menores. A sensibilização e orientação constante das famílias, a busca ativa e a adesão aos períodos de campanha são algumas condutas que precisam estar fortalecidas na rede básica. A integração com o serviço escolar, a exigência da caderneta de vacina atualizada para matrícula nas escolas e recadastramento no Bolsa Família são caminhos que podem fortalecer a imunização na infância.

CRIANÇA			
IDADE	**VACINA**	**DOENÇAS EVITÁVEIS**	**DOSE**
Ao nascer	BCG-ID	Previne as formas graves de tuberculose (miliar e meningea)	Dose única
	Hepatite B	Previne a hepatite B	Dose única
2 meses	Pentavalente (DTP + Hib + Hep. B)	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	1ª dose
	Poliomielite Inativada (VIP)	Previne a poliomielite (paralisia infantil)	
	Pneumocócica 10 – valente (conjugada)	Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo	
	Oral contra Rotavírus Humano (VORH)	Previne diarreia por rotavírus	
3 meses	Meningocócica C	Previne meningite e meningococcemia (infecção generalizada)	1ª dose